

Ihren autistischen Angehörigen bei der Arbeit unterstützen

Für Familie, Partner:innen und Freund:innen — einen autistischen Erwachsenen in Beschäftigung unterstützen.

Die Kernidee

Autismus bedeutet über den **Monotropismus**, dass sich die Aufmerksamkeit Ihres Angehörigen in wenige tiefe, intensive „Tunnel“ einschließt. Im richtigen Job ist das eine Superkraft — anhaltende Konzentration, Verlässlichkeit, Mustererkennung, Tiefe und Ehrlichkeit. Im falschen (Großraumbüros, ständige Unterbrechung, Büropolitik) treibt es chronische Erschöpfung, Masking und **autistisches Burnout**. Viele berufstätige autistische Erwachsene — besonders Frauen — wurden erst im Erwachsenenalter erkannt. Ihr Teil ist es, ihnen zu glauben, ihre Anpassungen zu stützen und zu helfen zu erkennen, wenn der Tank leer ist.

Was Sie beobachten könnten — und was wirklich dahintersteckt

Sie könnten sehen...	Was oft tatsächlich passiert
Erschöpft, erholt sich nach der Arbeit nicht, verliert Kompetenzen	Autistisches Burnout — von beruflichem Burnout und von Depression zu unterscheiden
In der Öffentlichkeit „gut“, bricht am Wochenende zusammen	Starkes Masking ; die Kosten werden ungesehen gezahlt
Konflikte mit einer Führungskraft; graut vor dem Büro	Oft ein Umwelt-Pass-Problem, kein Kompetenzproblem
Geht nicht zur Arztpraxis, ignoriert eigenen Schmerz oder Symptome	Interozeptions -Unterschiede — innere Signale registrieren sich nicht, wenn vertieft
Will einen ruhigeren Job, weniger Stunden oder eine Pause	Ein legitimer, evidenzangemessener Erholungsschritt, kein „Aufgeben“

Versuchen Sie dies

- **Glauben und validieren Sie** — spät-diagnostizierte Erwachsene werden von der Familie oft nicht geglaubt; Zuhören ist verwandelnd.
- **Stützen Sie Anpassungen und Rechte** (Gleichbehandlungsgesetz / ADA) — helfen Sie zu artikulieren, was hilft: ruhigerer Arbeitsplatz, schriftliche Anweisungen, weniger Meetings, asynchrone Kommunikation.
- **Nehmen Sie Burnout ernst** — wenn er ausbrennt, ist die evidenzgestützte Richtung **Anforderungen und Erwartungen reduzieren und Entmasken erlauben**, nicht „Durchziehen“.
- **Helfen Sie beim Praktischen**, wenn darum gebeten: HR navigieren, Arbeitsmedizin, Leistungen und Gesundheitsversorgung.
- **Achten Sie die Autonomie** — stützen Sie ihre Entscheidungen, einschließlich Stundenreduktion oder Rollenwechsel.

Vermeiden Sie dies

- Ihre öffentliche Fassung mit „gut sein“ gleichsetzen oder Erschöpfung als Faulheit abtun.
- Drängen zum „komm einfach mit den Leuten klar“ oder zu mehr Masking.

- Entscheidungen *über* sie *ohne* sie treffen.

Wann weitere Hilfe nötig ist

Achten Sie auf **autistisches Burnout** und **Suizidalität** — Burnout ist damit verknüpft. Behandeln Sie begleitende **ADHD (AuDHD), Angst, Depression, Schlaf- und GI-Zustände** mit autismus-informierten Kliniker:innen. Wo Burnout schwer ist, validieren Sie Auszeiten oder einen Rollenwechsel als Erholung, nicht als Schwäche.

Wenn Ihr/e Angehörige eine Frau ist

Frauen sind unter der „verlorenen Generation“ spät-diagnostizierter Erwachsener überrepräsentiert und masken am stärksten. Nehmen Sie ein lebenslanges Muster sozialer/sensorischer Unterschiede und privater Erschöpfung ernst, auch bei einem „erfolgreichen“ Äußeren.

Über diesen Leitfaden

KI-gestützt, abgeleitet aus den Forschungsentwürfen dieses Projekts — der Leitfaden für die **Familie** (Teil 4) und das **Monotropismus**-Dossier; mit dem Leitfaden für **Praktiker und Gesundheitsfachleute über die Lebensspanne** (Teil 3.4). Verwendet *identitätsfirst*-Sprache. **Information — kein medizinischer Rat und kein diagnostisches Werkzeug.** Passen Sie es an die einzelne Person an.

Schlüsselquellen. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020); Mantzalas et al. (2022); Pearson & Rose (2021); Knight (2021). Vollständige Nachweise finden sich in den Quelldossiers.